

Consent Information - Patient Copy Upper Gastrointestinal Endoscopy

معلومات الإقرار – نسخة المريض تنظير الجهاز الهضمي العلوي

1. What is an upper gastrointestinal endoscopy?

An upper gastrointestinal (GI) endoscopy is where the doctor uses an instrument called an endoscope to look at the inside lining of your oesophagus (food pipe), stomach and duodenum (first part of the small intestine). This is done to look at reasons as to why you may have swallowing problems, nausea, vomiting, reflux, bleeding, indigestion, abdominal pain or chest pain.

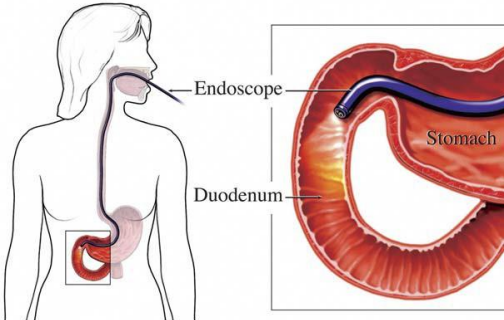
An endoscope is a long, thin, flexible tube with a small camera and light attached which allows the doctor to see the pictures of the inside of your gut on a video screen. The scope bends, so that the doctor can move it around the curves of your gut. The scope also blows air into your stomach; this expands the folds of tissue in your stomach so that the doctor sees the stomach lining better. As a result, you might feel some pressure, bloating or cramping during the procedure. This instrument can also be used to remove or burn growths or to take tissue biopsies.

You will then lie on your left side, and the doctor will pass the endoscope into your mouth and down your oesophagus (food pipe), stomach and duodenum (first part of the small intestine). Your doctor will examine the lining again as the endoscope is taken out.

The endoscope does not cause problems with your breathing.

You should plan on 2 to 3 hours for waiting, preparation and recovery. The procedure itself usually takes anywhere from 10 to 15 minutes.

If the doctor sees anything unusual or want to test for bacteria in the stomach they may need to take a biopsy (small pieces of tissue) for testing at Pathology. This procedure may or may not require a sedation anaesthetic.



2. Will there be any discomfort? Is any anaesthetic needed?

The procedure can be uncomfortable and to make the procedure more comfortable a sedative injection or a light anaesthetic can be given. If you prefer, it can be done without sedation.

Before the procedure begins the doctor:

- will put a drip into a vein in your hand or forearm. This

1. ما هو تنظير الجهاز الهضمي العلوي ؟

تنظير الجهاز الهضمي العلوي هو الإجراء الذي يستخدم فيه الطبيب أداة تسمى المنظار لرؤية البطانة الداخلية للمريء، المعدة، والإثنى عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة). يتم القيام بهذا الإجراء لمعرفة سبب ما قد تشعر به من مشاكل في البلع، غثيان، قيئ، ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، نزيف، عسر في الهضم، ألم في البطن أو الصدر.

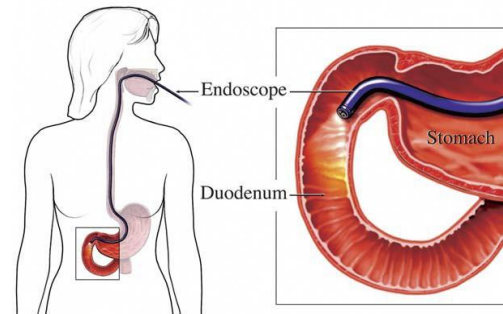
المنظار هو أنبوب طويل، رفيع ومرن مزود بكاميرا صغيرة ومصدر للضوء يمكن الطبيب من رؤية صور لأمعائك من الداخل على شاشة فيديو. يمكن للمنظار الالتواء مما يمكن الطبيب من تحريكه حول منحنيات الأمعاء. يقوم المنظار أيضاً بضخ هواء داخل المعدة مما يؤدي إلى تمدد طيات أنسجة المعدة ويعطي الطبيب رؤية أكثر وضوحاً لبطانة المعدة. لذا فإنك قد تشعر ببعض الضغط، انتفاخ أو مغص أثناء خضوعك للإجراء. يستخدم المنظار كذلك لإزالة أو لكي (حرق) أي نمو غير طبيعي للأنسجة أو لأخذ عينة للأنسجة.

يطلب من المريض أن يستلقي على جانبه الأيسر، ويقوم الطبيب بتمرير المنظار عبر الفم نزولاً إلى المريء، المعدة والإثنى عشر. وبينما يتم إخراج المنظار، يقوم الطبيب بفحص بطانة هذه الأجزاء مرة أخرى.

لا يسبب المنظار أي مشاكل في التنفس.

هئي نفسك لقضاء ما بين 2-3 ساعات في انتظار الإجراء، إنهاء التحضيرات المتعلقة به وإتمام فترة النقاهة التي تعقب الإجراء.

الإجراء بعد ذاته يستغرق عادةً ما بين 10 – 15 دقيقة. في حالة رؤية الطبيب لأمر غير معتاد أو أراد اختبار وجود البكتيريا في المعدة، فقد يتطلب الأمر أخذ عينة (أجزاء صغيرة من الأنسجة) ليتم فحصها في مختبر علم الأمراض. هذا الإجراء قد، أو قد لا يتطلب إعطاء دواء تخدير مسكن.



2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

هذا الإجراء قد لا يكون مريحاً، ولجعله مريحاً قد يتم إعطائك حقنة مسكنة (مخدر خفيف). إن كنت لا ترغب في ذلك، فيمكن القيام بالإجراء بدون الدواء المسكن.

قبل بداية الإجراء :

- يقوم الطبيب بتركيب خط وريدي لك في اليد أو الساعد موصلاً بمحلول. يتم حقن المسكن أو الدواء المخدر عن طريق هذا الخط الوريدي.

is where the sedation or anaesthetic is injected and

- may spray your throat with a numbing agent that will help prevent gagging.

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful.

You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

Anaesthesia is generally very safe but every anaesthetic has a risk of side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- Personal factors, such as whether you smoke or are overweight.
- Whether you have any other illness such as asthma, diabetes, heart disease, kidney disease, high blood pressure or other serious medical conditions.

4. What are the risks of this specific procedure +/- sedation?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Nausea and vomiting.
- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Headache.
- Pain, redness or bruising at the sedation injection site (usually in the hand or arm).
- Muscle aches and pains.
- Allergy to medications given at time of the procedure.

Uncommon risks and complications include:

- About 1 person in every 1,000 will experience bleeding from the oesophagus (food pipe), stomach and duodenum where a lesion or polyp was removed. This is usually minor and can usually be stopped through the endoscope. Rarely, surgery is needed to stop bleeding.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. Emergency treatment may be necessary.
- Damage to your teeth or jaw due to the presence of instruments in your mouth.
- An existing medical condition that you may have getting worse.

Rare risks and complications include:

- Missed polyps or growths.
- About 1 person in every 5,000 will accidentally get a hole (perforation) in the esophagus, stomach or duodenum. This can cause a leak of stomach contents

- قد يتم رش رذاذ مخدر في الحلق لمنع حدوث انقباض للحنجرة.

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟

هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم. قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء.

التخدير بشكل عام آمن جداً ، إلا أن لكل دواء تخدير مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم من أنها غالباً مؤقتة ، إلا أن

البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.
- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى كالربو الشعبي ، السكري ، مرض في القلب ، مرض في الكلى ، ارتفاع في ضغط الدم أو أي مشكلة طبية أخرى خطيرة.

4. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد + \ - الدواء المسكن ؟ لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مختصرة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- غثيان وقيئ.
- إغماء أو دوخة خاصة بعد البدء في ممارسة الحركة.
- صداع.
- ألم ، احمرار أو كدمة في موضع حقن المخدر (عادة في اليد أو الذراع).
- أوجاع وآلام في العضلات.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عند تقريباً مريض واحد من بين كل 1000 مريض ، يحدث نزيف من المريء ، المعدة والإثنى عشر في الموضع الذي تم فيه إزالة مرض أو ورم (السليلة المخاطية). عادة ما يكون النزيف محدوداً و يمكن إيقافه باستخدام المنظار. من النادر أن تكون هناك حاجة لجراحة لإيقاف النزيف.
- مشاكل في القلب والرئة كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً حيث يتطلب ذلك معالجة طارئة.
- ضرر يصيب الأسنان أو الفك بسبب وجود أدوات الإجراء داخل الفم.
- تفاقم أي مشكلة طبية أخرى يعاني منها المريض.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- عدم التنبيه لوجود نمو غير طبيعي في الأنسجة أو لورم (السليلة المخاطية).
- عند مريض واحد من بين كل 5000 مريض ، يحدث بالخطأ انتقاب للمريء ، المعدة أو الإثنى عشر ، مما قد يسبب تسرب محتويات المعدة إلى

into the abdomen. If a hole is made, you will be admitted to hospital for further treatment which may include surgery.

- Your procedure may not be able to be finished due to problems inside your body or because of technical problems.
- Bacteremia (infection in the blood). This will need antibiotics.
- 'Dead arm' type feeling in any nerve, due to position with the procedure – usually temporary.
- Anaphylaxis (severe allergy) to medication given at the time of procedure.
- Death as a result of complications to this procedure is rare.

5. What are your responsibilities before having this procedure?

You are less at risk of problems if you do the following:

- Tell your doctor if you could be pregnant as X- rays are used as part of the procedure.
- Bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements and show your doctor what you are taking. Tell your doctor about any allergies or side effects you may have.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure. If you have a drug habit please tells your doctor.
- If you take Warfarin, Persantin, Clopidogrel (Plavix or Iscover), Asasantin or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting. Do not stop taking them without asking your doctor.
- Tell your doctor if you have:
 - had heart valve replacement surgery.
 - received previous advice about taking antibiotics before a dental treatment or a surgical procedure.

6. Preparation for the procedure

You should not eat or drink anything for at least 6 hours before the procedure to make sure you have an empty stomach, which is necessary for a safe examination.

7. What if the doctor finds something wrong?

Your doctor may take a biopsy (a very small piece of the bowel lining) to be examined at Pathology. Biopsies are used to identify many conditions even if cancer is not thought to be the problem.

8. What if I don't have the procedure?

Your symptoms may become worse and the doctor will not be able to give you the correct treatment without knowing the cause of your problems.

9. Are there other tests I can have instead?

Generally not. An MRI scan can be used to gather

البطن . إذا حدث الانتفاخ ، يتم تنويم المريض في المستشفى لإعطاء معالجات أخرى قد يكون من ضمنها إجراء جراحة.

- قد لا يكون من الممكن إنهاء الإجراء بسبب مشاكل في جسم المريض أو بسبب مشاكل فنية (تقنية).
- بكتيريا في الدم (عدوى في الدم). يتطلب ذلك مضادات حيوية.
- الذراع الميت " شعور يحدث لأي عصب نتيجة تضرره بوضعية المريض أثناء الإجراء. عادةً يكون مؤقتاً.
- الحساسية المفرطة (حساسية شديدة) بسبب الأدوية المعطاة أثناء الإجراء.
- الوفاة نادرة بسبب مضاعفات هذا الإجراء.

5. ما هي مسئوليات المريض قبل الخضوع لهذا الإجراء؟

- أبلغ الطبيب إن كنت حاملاً لأنه يتم استخدام الأشعة السينية كجزء من هذا الإجراء.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية ، وأبلغ طبيبك بكل ما تتناوله منها. أبلغ طبيبك بكل أنواع الحساسية لديك وأي آثار جانبية قد سبق تعرضك لها.
- لا تحتس الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير الترفيهية التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء. نرجو إبلاغ الطبيب إذا كان لديك تعود على أي دواء.
- إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالوارفرين ، بيرسانتين ، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو اساسانتين أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك
- إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك. لا تتوقف عن تناولها دون مشاورة طبيبك.
- أبلغ طبيبك إن كنت:
 - قد خضعت لجراحة استبدال صمام في القلب.
 - سبق وأن تم نصحك بتناول المضادات الحيوية قبل أي إجراء في الأسنان أو أي إجراء جراحي .

6. التحضير للإجراء

يجب أن لا تتناول أي طعام أو شراب لست (6) ساعات قبل الإجراء للتأكد من خلو معدتك . هذا الأمر مهم لإجراء آمن.

7. ماذا لو اكتشف الطبيب وجود أمر مخالف للمألوف؟

قد يقوم الطبيب بأخذ خزعة (عينه) وهي جزء صغير جداً من الغشاء المبطن للأمعاء ليتم فحصها من قبل مختبر علم الأمراض. يستفاد من مثل هذه العينات في تشخيص العديد من الأمراض حتى لو لم يكن السرطان في الحسبان كسبب لما تعانيه.

8. ماذا لو لم أخضع للإجراء؟

قد تزداد الأعراض لديك سوءاً ولا يتمكن الطبيب من وصف العلاج الصحيح لك دون أن يكون على علم تام بسبب ما تعانيه من مشاكل.

9. هل بإمكانني الخضوع لأي اختبارات أخرى بديلة لهذا الإجراء؟

بشكل عام لا يوجد . يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

some information but cannot be used for treatment. Other treatment options include drainage under X-ray control and surgery.

10. What can I expect after this procedure?

Usually you remain in the recovery area for about 2 hours until the effect of the sedation wears off. Your doctor will tell you when you can eat and drink. Most times this is straight after the procedure.

You may experience bloating or pass wind because of the air introduced during the procedure.

You will be told what was found during the examination or you may need to come back to discuss the results, and to find out the results of any biopsies that may have been taken. Your doctor may recommend dietary restrictions for 1-2 days after the procedure.

11. What are the safety issues?

Sedation will affect your judgment for about 24 hours. For your own safety and in some cases legally;

- Do **NOT** drive any type of car, bike or other vehicle. You must be taken home by a responsible adult person.
- Do **NOT** operate machinery including cooking implements.
- Do **NOT** make important decisions or sign a legal document.
- Do **NOT** drink alcohol, take other mind-altering substances, or smoke. They may react with the sedation drugs.
- Have an adult with you on the first night after your colonoscopy.

Notify the hospital Emergency Department straight away if you have;

- Severe ongoing abdominal pain.
- A fever.
- Sharp chest or throat pain.
- Have redness, tenderness or swelling for more than 48 hours where you had the injection for sedation (either in the hand or arm).
- Bleeding which can occur up to 3 weeks after the procedure. Symptoms of bleeding include dizziness, fainting or passing blood or black bowel movements.

Notes to talk to my doctor about:

بعض المعلومات ، ولكن لا يمكن استخدامه في العلاج. من بدائل العلاج الأخرى استخدام الأشعة السينية في سحب المواد ، وكذلك الجراحة.

10. ما الذي يمكنني توقعه بعد هذا الإجراء؟

عادةً ، تظل في غرفة الإفاقة لساعتين حتى ينتهي مفعول الدواء المسكن. سيبلغك طبيبك عن الوقت الذي يمكنك فيه تناول الطعام والشراب، وعادةً ما يكون ذلك مباشرة بعد الإجراء. قد تشعر بالانتفاخ وقد تخرج منك غازات بسبب الهواء الذي تم إدخاله أثناء الإجراء.

سوف يتم إبلاغك بنتائج الإجراء ، وقد يطلب منك العودة من أجل مناقشة ذلك في وقت آخر وللتعرف أيضاً عند نتائج فحص العينات

إن كانت قد أخذت.

قد ينصح الطبيب بنظام غذائي محدد ليوم أو يومين بعد الإجراء.

11. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة؟

يؤثر الدواء المسكن لحوالي 24 ساعة على قدرتك في اتخاذ القرار. لضمان سلامتك ولأخذ الأمور القانونية بعين الاعتبار :

- لا تقد أي نوع من المركبات كالسيارة أو الدراجة أو غيرها. يجب أن يرافقك إلى المنزل شخص عاقل بالغ ومسؤول عند خروجك من المستشفى.
- لا تقم بتشغيل أي آلات بما في ذلك أدوات الطهي.
- لا تتخذ أي قرار مهم ولا تقم بتوقيع أي مستند قانوني.
- لا تحتسي الكحول أو تتناول أي من المواد المسببة للهلوسة ، ولا تدخن . كل ذلك قد يتفاعل مع الدواء المسكن.
- استعن بشخص بالغ يظل بجوارك في الليلة الأولى بعد الإجراء.

قم فوراً بإبلاغ قسم الطوارئ في المستشفى إذا شعرت بـ :

- ألم شديد ومتواصل في البطن .
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- ألم حاد في الصدر أو الحلق.
- إذا كانت المنطقة التي تلقيت فيها إبرة الدواء المسكن (في اليد أو الذراع) حمراء ، مؤلمة عند لمسها أو متورمة لأكثر من 48 ساعة بعد الإجراء
- نزيف قد يستمر لفترة ثلاث أسابيع بعد الإجراء. علامات النزيف تشمل الدوخة، الإغماء ، خروج دم البراز (براز أسود).

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
